Hôpital Paris Saint-Joseph

MEDI MEMO SAUV

SERVICE DES URGENCES

ANNEE 2026

MIS A JOUR ET MIS EN PAGE PAR MR G. SILVETTI

RELECTURE ET CORRECTION T. PRUNIER - DR. R. MIJAHED – DR O. GANANSIA

ANTALGIQUES 4

MORPHINE (Morphine®)

ANTIARYTHMIQUES 7

ATROPINE (Atropine®)
AMIODARONE (Cordarone®)
DIGOXINE (Digoxine®)
ADENOSINE (Striadyne®)

ANTICOAGULANTS 13

HEPARINE SODIQUE (Héparine®)

ANTIDOTES 16

ACETYLCYSTEINE (Hidonac®)
FLUMAZENIL (Anexate®)
NALOXONE (Narcan®)
OCTAPLEX (Confidex®)
SUGAMMADEX (Bridion®)

ANTIHYPERTENSEURS 24

ISOSORBIDE (Risordan®)
NICARDIPINE (Loxen®)
URAPIDIL (Eupressyl®)

CATHECHOLAMINES 28

ADRENALINE (Adrénaline®)
DOBUTAMINE (Dobutrex®)
EPHEDRINE (Ephédrine®)
ISOPRALINE (Isuprel®)
NORADRENALINE (Noradrénaline®)

CURARES 38

ATRACURIUM (Tracrium®)
ROCURONIUM (Esmeron®)
SUXAMETHONIUM (Célocurine®)

DIVERS 42

ACIDE TRANEXAMIQUE (Exacyl®)
GLUCAGON (Glucagen®)
GLUCONATE DE CALCIUM
INSULINE (Actrapid®)

ENTRETIEN 48

MIDAZOLAM (Hypnovel®)
SUFENTANYL (Sufenta®)

INDUCTION 51

ETOMIDATE (Hypnomidate®)
KETAMINE (Kétamine®)
PROPOFOL (Diprivan®)

THROMBOLYTIQUE 57

ACTILYSE (Altéplase®)

AUTRES 60

INDUCTION
ENTRETIEN - SEDATION
DROGUE CHARIOT URG
VENTILATION

KTC
KTA
KT INTRA OSSEUX
DRAIN THORACIQUE

LEGENDE

FICHE THERAPEUTIQUE

- NOM MEDICAMENT
- INDICATION
- PRESENTATION
- DELAI D'ACTION
- DUREE D'ACTION
- PRECAUTIONS / RISQUES
- PREPARATION
- ADMINISTRATION

ICONES


AMPOULE


SOLVANT


FLACON


POCHON

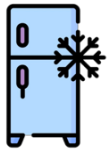

POMPE A PERFUSION


CHARIOT D'URGENCE


COFFRE DE STUPEFIANT


PHARMACIE HÔPITAL


PHARMACIE SERVICE


FRIGO SERVICE

ANTALGIQUE PALLIER III

MORPHINE

Indication

Analgésie vigile

Délai d'action



5 minutes
Effet max à 20 minutes

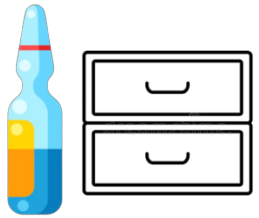
Durée d'action



2 à 3 heures

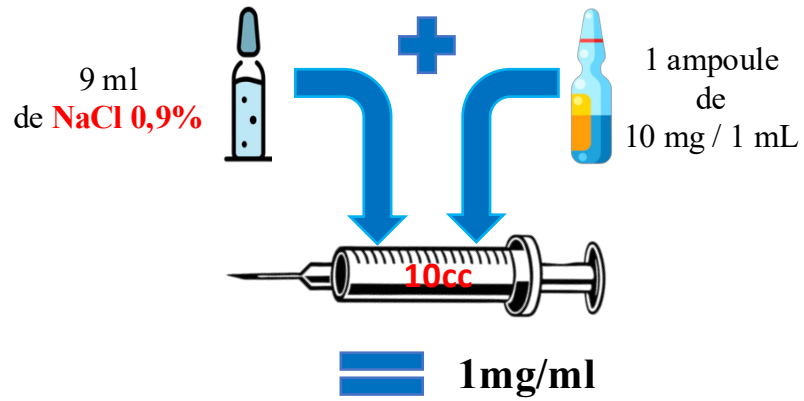
Présentation

Ampoule
10 mg dans 1 ml
100 mg dans 10 ml



Préparation

DILUE



Précautions / Risques

Monitorage, surveiller FR (Majoration de la FR avec les Benzodiazépine)
Contre indiqué si : Insuffisance hépatocellulaire sévère, TC et HTIC épilepsie non contrôlé, hypovolémie, insuffisance rénale, syndrome occlusif

Administration

IVD – Titration : 1-3mg /5min

MORPHINE

Indication

Analgésie sous hypnotique (fin de vie ou avec IOT)

Délai d'action



5 minutes
Effet max à 20 minutes

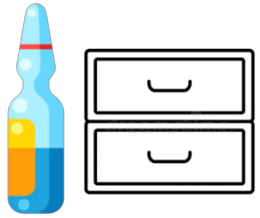
Durée d'action



2 à 3 heures

Présentation

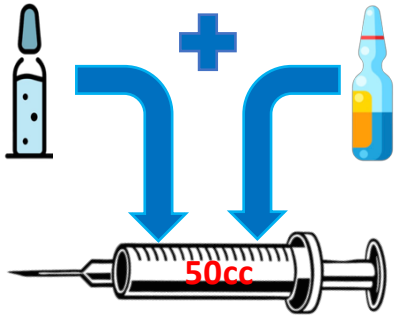
Ampoule
10 mg dans 1 ml
100 mg dans 10 ml



Préparation

DILUE

45 ml
de **NaCl 0,9%**



0,5 ampoule
de
100 mg / 10 mL

1mg/ml

Précautions / Risques

Monitorage, surveiller FR
Majoration de la FR avec les Benzodiazépine
Contre indiqué si : Insuffisance hépatocellulaire sévère, TC et HTIC épilepsie non contrôlé, hypovolémie, insuffisance rénale, syndrome occlusif

Administration

IVSE – 1-5 mg/h

ANTIARYTHMIQUES

ATROPINE

Indication

Bloc auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire et bradycardies sinusales

Présentation

Ampoule
0,5 mg dans 1 ml



Délai d'action



30 à 60 secondes

Durée d'action



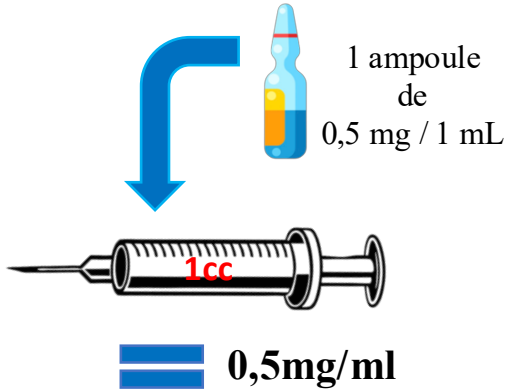
2 à 3 heures

Précautions / Risques

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments au moment de l'emploi
Ne pas utiliser en cas de : risque de glaucome, iléus paralytique et troubles urétro-prostatiques avec risque de rétention urinaire

Préparation

PUR



0,5mg/ml

Administration

IVD – 0.5 à 1mg à répéter si nécessaire toutes les 3 minutes dose maximal de 3mg

AMIODARONE

Indication

ACR

Présentation

Ampoule
150 mg dans 3 ml



Délai d'action



Pic max dans les
15 minutes

Durée d'action



4 heures

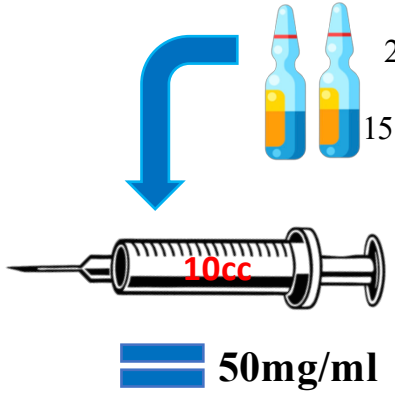
Précautions / Risques

Diluer dans G5% uniquement
Veinite : bien rincer sur voie périphérique après le passage

Préparation

1 1ère seringue

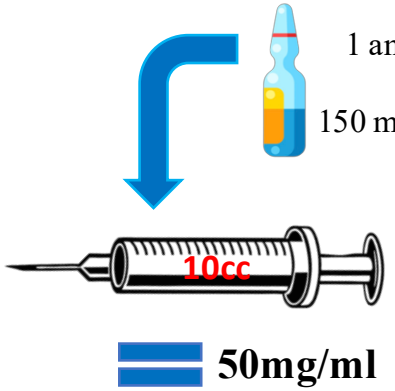
PUR



50mg/ml

2 2ème seringue

PUR



50mg/ml

Algorithme au verso

Administration

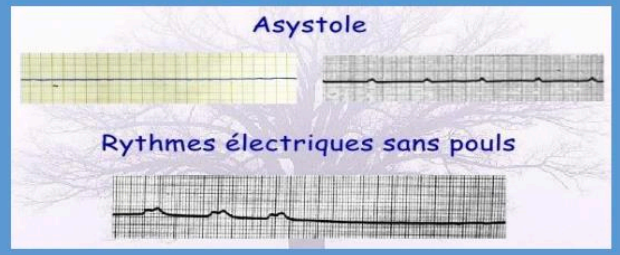
IVD – 300 mg au 3ème CEE + 150 mg au 5ème CEE si besoin

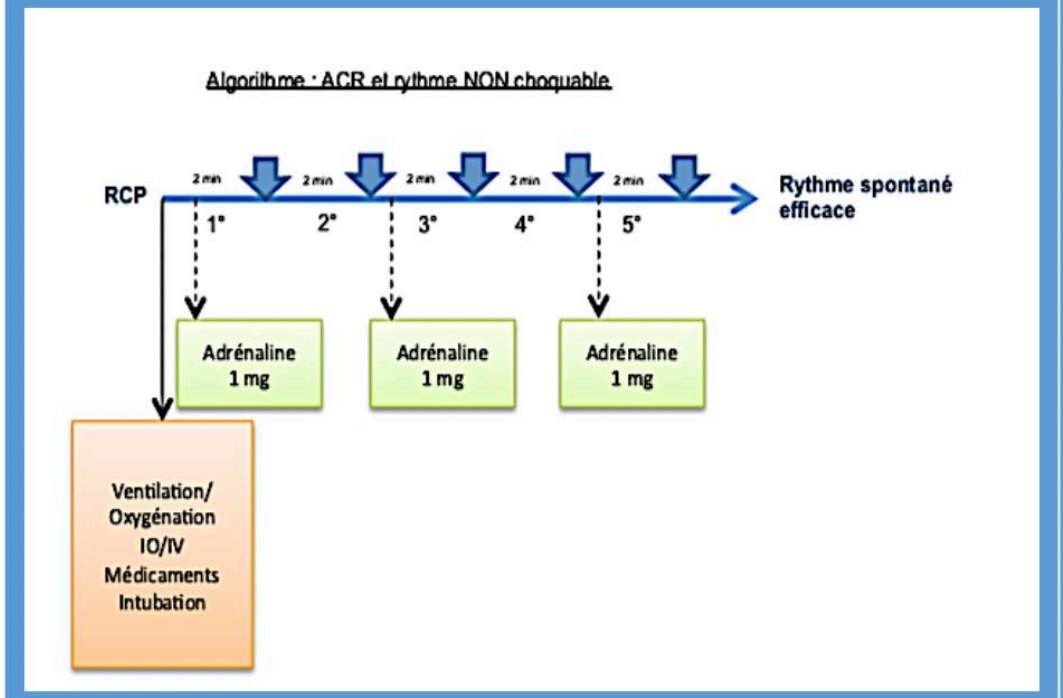
AMIODARONE

Indication

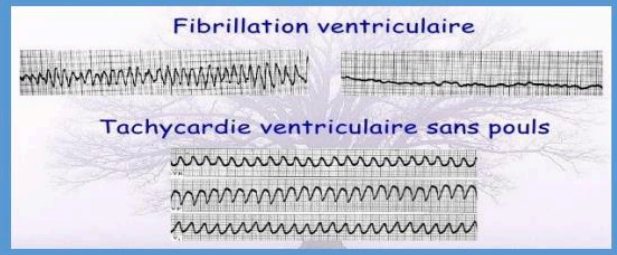
ACR

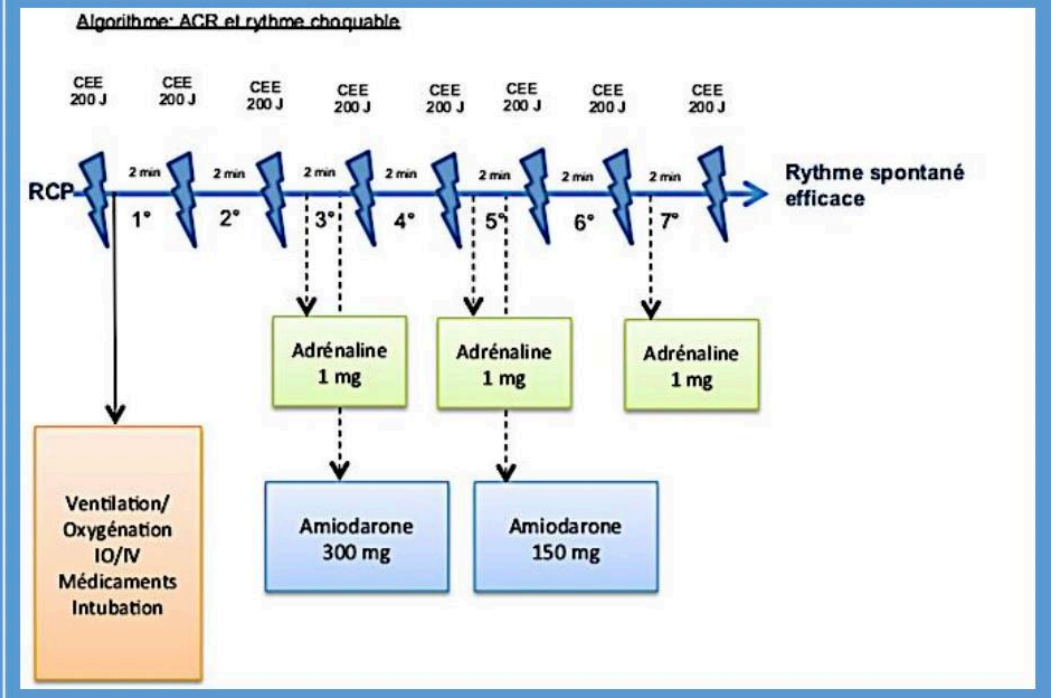
RYTHME NON CHOQUABLE





RYTHME CHOQUABLE





DIGOXINE

***Ralentissement ou réduction de la fibrillation auriculaire ou du flutter auriculaire**

Présentation

Ampoule
0,5 mg dans 2 ml



⚠ Précautions / Risques ⚠

BAV du 2ème et du 3ème degré non appareillés, syndrome de Wolff-Parkinson-White, tachycardie & fibrillation ventriculaires, hypokaliémie non corrigée, association au sultopride, au calcium (sels de)

Indication

Troubles du rythme supraventriculaire*

Délai d'action



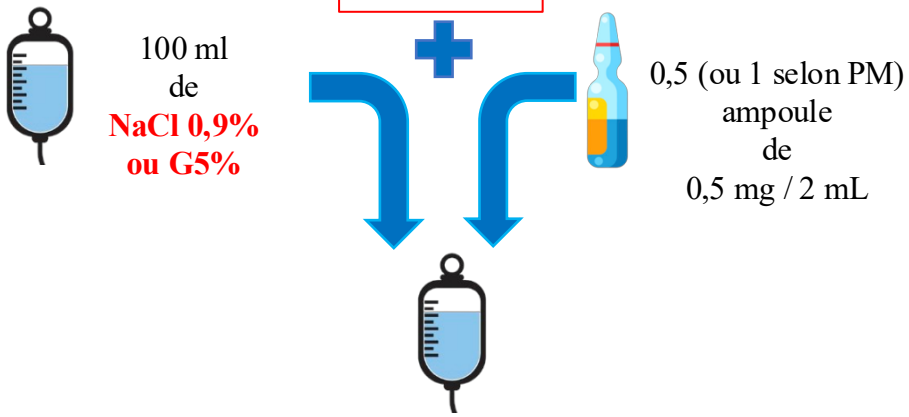
10 à 30 minutes

Durée d'action



Plus de 30 heures

Préparation



Administration

IVL – perfusion sur 15 minutes

ADENOSINE

Indication

Tachycardie jonctionnelle

Délai d'action

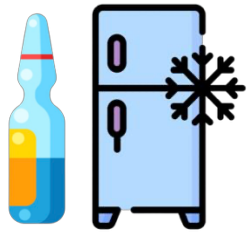


Durée d'action



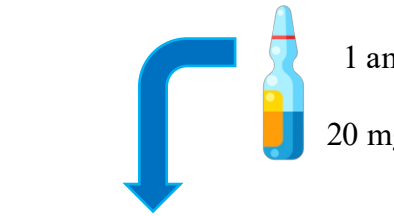
Présentation

Ampoule
20 mg dans 2 ml



Préparation

PUR



10mg/ml

Précautions / Risques

Sous enregistrement ECG en continu, flush de NaCl après IVD, risque de pause sinusale donc toujours préparer 1 amp de 0,5mg Atropine avant injection
Contre indiqué pour BAV 2 et 3 sauf si porteur d'un stimulateur cardiaque, asthme

Administration

IVD – 10 mg
Si pas d'arrêt de la tachycardie supraventriculaire, après 2/3 min → passer 20 mg en IVD

ANTICOAGULANTS

HEPARINE SODIQUE

Présentation

Flacon
25 000 UI dans 5 ml




Précautions / Risques

Antécédents de thrombopénie grave de type II, HTA non contrôlée, endocardite infectieuse aiguë, troubles de l'hémostase, pathologies potentiellement hémorragiques, AVC ischémique en phase aigüe

Indication

TVP, EP, IDM en phase aigüe, embolies artérielles extra-cérébrales

Délai d'action



< 1 minutes

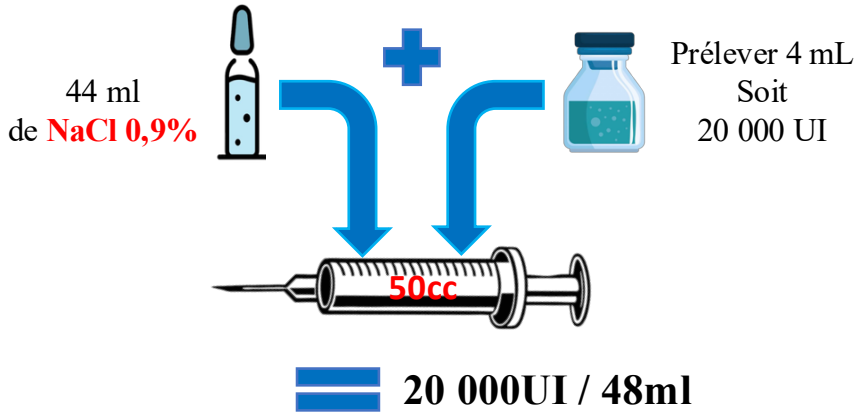
Durée d'action



2 à 4 heures

Préparation

DILUE



20 000UI / 48ml

Tableau au verso

Administration

IVD – 50 UI/kg (max 5.000 UI en IVD) / **IVSE** – 20 UI/kg/h
Surveillance : Dosage de l'Anti-Xa 4h après début de IVSE

HEPARINE SODIQUE

Indication

TVP, EP, IDM en phase aigüe, embolies artérielles extra-cérébrales

HÔPITAUX Paris Saint Joseph Marie Lannelongue

Protocole de Prescription/ Surveillance de l'héparine IV (HNF)
Fort – Cible Anti-Xa 0.5 à 0.7

Référence : PHARMA-PROT-896

Version : 1

Etiquette patient

Date de début : (à renouveler tous les 3 jours)

Diagnostic : Nom prescripteur

Poids Signature

❒ Bolus IVD : 50UI/kg soit …… (maximum 5 000UI)

Préparation PSE : Conditionnement de l'héparine Sodique : Flacon de 25 000UI/ 5mL.
Diluer 20 000UI d'héparine sodique (soit 4mL) dans 44mL de NaCl 0.9%, pour obtenir une seringue de 20 000UI dans 48 mL.

Perfusion IVSE initiale (320 UI/kg/j) à la vitesse correspondance au poids le plus proche de celui du patient (intervalle +/- 1kg) : mettre en évidence la vitesse de départ

Faire un Anti-Xa HNF 4 heures après le bolus, puis 4 à 6 heures après chaque changement de dose.

Refaire impérativement la seringue à H24 (HNF sodique : 24H de stabilité en solution.

	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
Poids	**41**	**44**	**47**	**50**	**53**	**56**	**59**	**62**	**66**	**69**	**72**	**75**	**78**	**81**	**84**	**87**	**91**	**94**	**97**	**100**	**103**	**106**	**109**	**112**
Vitesse HNF IVSE Ml/h	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Equivalent en UI/j	13 000	14 000	15 000	16 000	17 000	18 000	19 000	20 000	21 000	22 000	23 000	24 000	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	31 000	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000

Fait le …….. à ……H Validation IDE :

Adaptation de la dose en fonction de l'anti-Xa			
Anti-Xa HNF	**Arrêt Perfusion**	**Adaptation ml/h**	**Contrôle antiXa**
< 0,1	Non	Médecin	H5
0,1 à 0,3	Non	↗ 0,3 ml/h	H5
0,3 à 0,5	Non	↗ 0,2 ml/h	H5
0,5 à 0,7	Non	Inchangée	Lendemain
0,7 à 0,9	60 min	↘ 0,2 ml/h	H5
>0,9	60 min	↘ 0,3 ml/h	H5

Suivi des adaptations de vitesse du PSE en fonction des dosages de l'anti-Xa HNF											
Date											
Heure prelev / Modif											
Anti-Xa HNF											
Vitesse PSE											
Validation IDE											
Validation Médicale											

L'anti Xa HNF doit être fait systématiquement sur un bon d'urgence

Date de création : 21/02/2025

Date de modification : 21/02/2025

ANTIDOTES

ACETYLCYSTEINE

Indication

Intoxication au paracétamol

Délai d'action

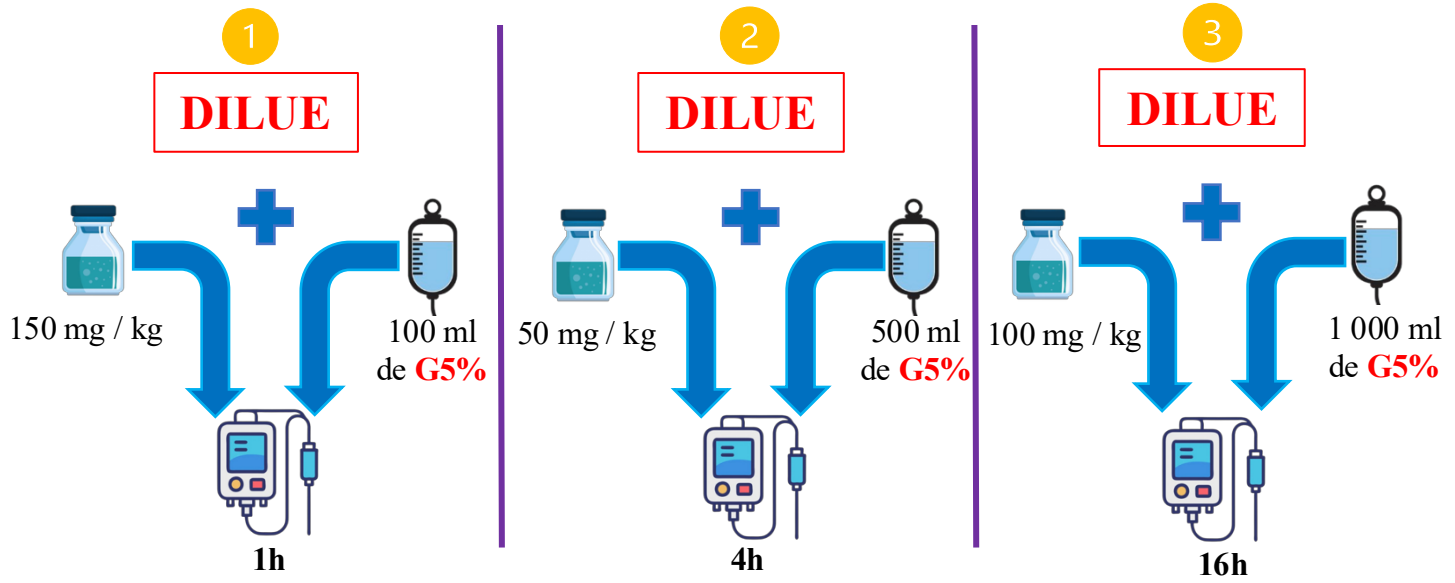
Durée d'action

Présentation

Flacon
5 g dans 25 ml



Préparation



Précautions / Risques

Privilégier le G5% au NaCl

Risque de Rash cutanée (si passage rapide, ralentir).

Administration

IVL pompe à perfusion (Infusomat)

Tableau au verso

ACETYLCYSTEINE

Indication

Intoxication au paracétamol

Prescription d'acétylcystéine chez l'adulte (chaque flacon = 5g / 25ml d'acétylcystéine)			Prière d'entourer le poids, la dose et le volume appropriés.			
Schéma	Première perfusion		Deuxième perfusion		Troisième perfusion	
Liquide de perfusion	200 ml de soluté glucosé à 5 % ou chlorure de sodium à 0,9 %		500 ml de soluté glucosé à 5 % ou chlorure de sodium à 0,9 %		1000 ml de soluté glucosé à 5 % ou chlorure de sodium à 0,9 %	
Durée de la perfusion	1 heure		4 heures		16 heures	
Dose du médicament	150 mg/kg acétylcystéine		50 mg/kg acétylcystéine		100 mg/kg acétylcystéine	
Poids du patient[1]	Volume d'Hidonac[2]	Vitesse de perfusion	Volume d'Hidonac [2]	Vitesse de perfusion	Volume d'Hidonac[2]	Vitesse de perfusion
kg	ml	ml/h	ml	ml/h	ml	ml/h
40-49	34	234	12	128	23	64
50-59	42	242	14	129	28	64
60-69	49	249	17	129	33	65
70-79	57	257	19	130	38	65
80-89	64	264	22	131	43	65
90-99	72	272	24	131	48	66
100-109	79	279	27	132	53	66
> 110 – dose max.	83	283	28	132	55	66

FLUMAZENIL

Indication

Intoxication aux BZD avec Glasgow < 10

Présentation

Ampoule
1 mg dans 10 ml



Délai d'action



1 à 2 minutes

Durée d'action



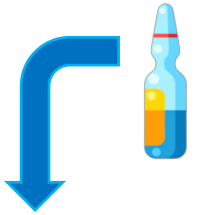
1 à 4 heures

Précautions / Risques

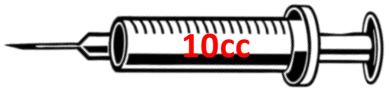
Ne pas utiliser en cas de :
état de mal épileptique, intoxications poly médicamenteuses

Préparation

PUR



1 ampoule
de
1 mg / 10 mL



0,1mg/ml

Pensez à préparer une dose d'entretien en IVSE

Administration

IVD – titration débutée à 0,2mg puis réitérer toutes les 60 secondes par palier de 0,1mg jusqu'au réveil - Dose maximale 1mg soit une ampoule

NALOXONE

Indication

Intoxication aux opiacés avec score : Glasgow < 9 et FR < 10)

Délai d'action

30 secondes

Durée d'action

20 à 30 minutes

Présentation

Ampoule
0,4 mg dans 1 ml



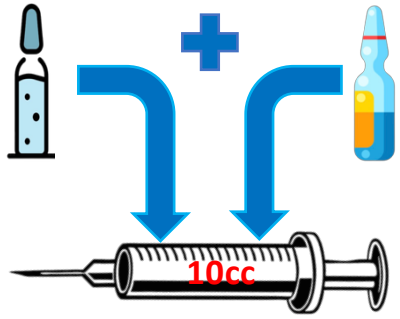
Précautions / Risques

Réveille parfois brutal

Préparation

DILUE

9 ml
de **NaCl**
0,9%



1 ampoule
de
0,4 mg / 1 mL

0,04mg/ml

Pensez à préparer une dose d'entretien en IVSE

Administration

IVD – 1mL toutes les 2 minutes jusqu'à FR > 12 sans un réveil complet nécessaire

OCTAPLEX

Présentation

Flacon
De 500 UI & de 20 ml



Précautions / Risques

Veiller à ce que le sang ne pénètre pas dans la seringue remplie (risque de coagulation et d'administration des caillots)
Vérification du pouls avant et pdt la perfusion (si = diminution débit ou arrêt)

Pas de mélange à d'autres médicaments, solution limpide ou légèrement opalescente (inspection visuelle de la solution reconstituée)

A utiliser immédiatement mais stabilité après reconstitution = 8h à température ambiante

Indication

Accident hémorragique en cas de surdosage d'AVK ou d'AOD

Délai d'action



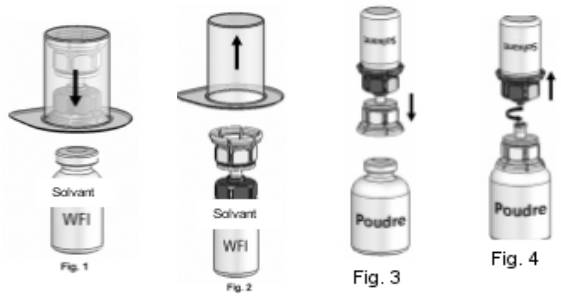
30 minutes

Durée d'action



Préparation

DILUE



1. Placez la partie bleue du Mix2Vial sur le dessus du flacon d'eau PPI et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 1).
2. Retirez l'emballage externe du Mix2Vial, attention à bien laisser le Mix2Vial fermement fixé au flacon de solvant (Fig. 2)
3. Prendre le flacon de solvant avec le Mix2Vial fixé et le retourner.
4. Placer la partie transparente sur le dessus du flacon de poudre et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig 3) : Le solvant s'écoule automatiquement dans le flacon de poudre.
5. Les 2 flacons toujours fixés, tourner doucement le flacon de poudre jusqu'à ce que le produit soit dissous.
   OCTAPLEX **légèrement bleue** se dissout rapidement à température ambiante pour donner une solution **incolore** à.
6. Dévisser le Mix2Vial en 2 parties (Fig 4).
   Fixez une seringue de 40 mL (1 000 UI) à la partie transparente du Mix2Vial. Retournez le flacon et prélevez la solution dans la seringue.
7. Dès que la solution a été transférée, tenez fermement le piston de la seringue (en la tenant tournée vers le bas) et retirez la seringue du Mix2Vial.

Tableau au verso

Administration

IVSE – par pallier de 30min (si pas d'augmentation de la FC)
Initial : 60 mL/heure (V60) → 120mL/h (V120) → 180mL/h (V180)

OCTAPLEX

Indication

Accident hémorragique en cas de surdosage d'AVK ou d'AOD

Posologie de 25 UI/kg												
Poids	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**
Dose UI	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500
Volume à passer (mL)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Débit initial (mL/min)	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8	8	8	8	8	8	8
Le pouls du patient doit être pris avant et pendant la perfusion.												
Débit maximal 8 mL/min En cas d'augmentation nette du pouls, la vitesse de perfusion doit être réduite ou l'administration doit être interrompue.												
Durée Perfusion (min)	9	9	9	9	9	9	10	10	11	12	12	13

Posologie de 50 UI/kg												
Poids	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Dose UI	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
Volume à passer (mL)	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Débit initial (mL/min)	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8	8	8	8	8	8	8
Le pouls du patient doit être pris avant et pendant la perfusion.												
Débit maximal 8 mL/min En cas d'augmentation nette du pouls, la vitesse de perfusion doit être réduite ou l'administration doit être interrompue.												
Durée Perfusion (min)	17	17	17	17	17	18	19	20	22	23	24	25



Du sang ne doit pas refluer dans la seringue en raison du risque de formation de caillot de fibrine

Débit d'administration

	Débit d'administration
Initial	1ml/min (= 60mL/h) pendant 30min soit 30ml (750UI) sur 30min
Si absence de réaction (augmentation du pouls)	2ml/min (=120mL/h) pendant 30min soit 60ml (1500UI) sur 30min
Si absence de réaction	Possibilité de passer à 3ml/min(= 180mL/h) MAXIMUM (soit 75 UI/min)

Hémorragies sous AVK :

Si l'INR est indisponible, suivre les recommandations de la HAS → 25 UI/kg

Si INR disponible :

Max : 3 000 UI soit 120mL

INR initial	Dose en ml/kg de poids corporel
2-2,5	0,9-1,3
2,5-3,0	1,3-1,6
3,0-3,5	1,6-1,9
>3,5	>1,9

Hémorragies sous AOD :

Posologie recommandée :

50 UI/kg

Pas de doses maximales

MDS

Etiquettes des flacons à coller sur la fiche de traça de délivrée par la pharmacie et faxer (39 15)

SUGAMMADEX

Indication

Décurarisation après bloc neuromusculaire induit par Rocuronium ou Vécuronium

Présentation

Ampoule
500 mg dans 5 ml



Délai d'action



3 minutes

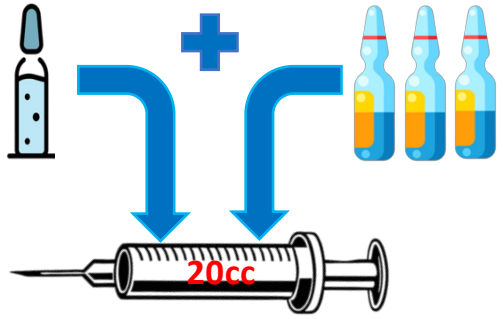
Durée d'action



Préparation

DILUE

5 ml
de **NaCl 0,9%**



3 ampoules
de
500 mg / 5 mL

75mg/ml

Précautions / Risques

Surveillance accrue de la fonction respiratoire

Avoir à disposition le matériel d'assistance respiratoire
Risque hémorragique si patient ayant des troubles de l'hémostase

Administration

IVD – 16mg/kg

ANTIHYPERTENSEURS

ISOSORBIDE

Indication

OAP hypertensif, angor instable

Présentation

Ampoule
10 mg dans 10 ml



Délai d'action



20 minutes

Durée d'action



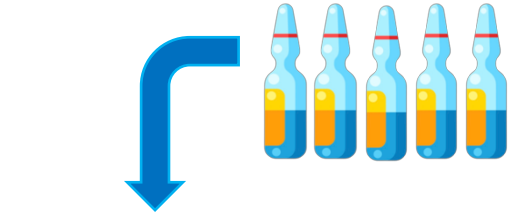
2 heures

Précautions / Risques

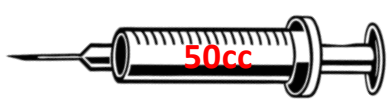
Adaptation posologique toutes les 45 min, choc hypovolémique, hypotension artérielle, hypertension intracrânienne

Préparation

PUR



5 ampoules
de
10 mg / 10 mL



1mg/ml

Administration

IVD – Dose initiale : 0,5 à 3 mg puis relais IVSE
IVSE – 1 à 15 mg/h

NICARDIPINE

Indication

Urgences hypertensives, dissection aortique

Présentation

Ampoule
10 mg dans 10 ml



Délai d'action



30 secondes

Durée d'action



10 à 20 minutes

Préparation

PUR



5 ampoules
de
10 mg / 10 mL



1mg/ml

Seringue opaque

Précautions / Risques

Ne pas dépasser 15 mg/h
Conservation à abri de la lumière
Incompatible avec les solutions alcalines (Bicarbonates), soluté de Ringer, Diazépam et Furosémide

Administration

IVSE – 1 à 15 mg/h & Augmenter par palier de 0,5 ou 1mg .

URAPIDIL

Présentation

Ampoule
50 mg dans 10 ml



Précautions / Risques

HTA chez AVC, HTA durant grossesse, sténose de l'isthme aortique ou shunt artério-veineux

Indication

HTA avec atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à court terme

Délai d'action



60 secondes

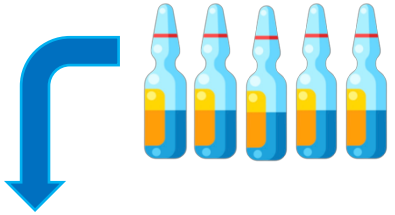
Durée d'action



66 à 80 minutes

Préparation

PUR



5 ampoules
de
50 mg / 10 mL



5mg/ml

Administration

IVSE – bolus de 25 mg en 20sec puis Dose d'entretien : 9 à 60 mg/h

CATHECHOLAMINES

ADRENALINE

Indication

ACR

Délai d'action



30 secondes

Durée d'action



3 minutes

Présentation

Ampoule

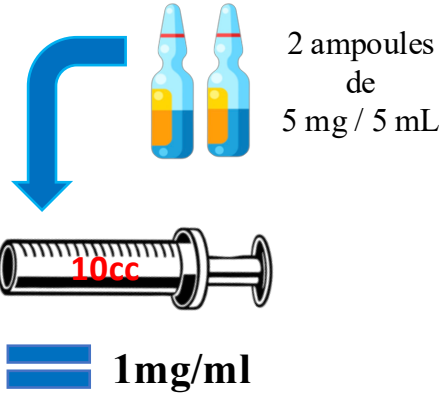
1mg dans 1 ml

5 mg dans 5 ml



Préparation

PUR



1mg/ml

Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée

Jamais de bolus

Incompatible avec du G5% ou solutés alcalins (bicarbonate, Phénytoïne, Lidocaïne)

Administration

IVD – 1mg/3min

ADRENALINE

Indication

ACR enfant

Délai d'action

30 secondes

Durée d'action

3 minutes

Présentation

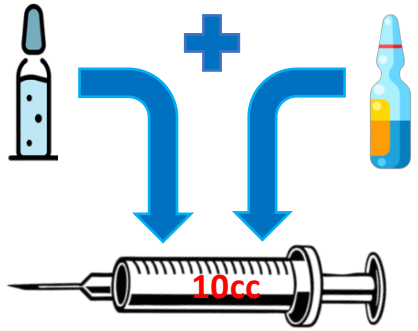
Ampoule
1mg dans 1 ml
5 mg dans 5 ml



Préparation

DILUE

9 ml
de **NaCl 0,9%**



1 ampoule
de
1 mg / 1mL

0.1mg/ml

Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée
Jamais de bolus

Incompatible avec du G5% ou solutés alcalins (bicarbonate, Phénytoïne, Lidocaïne)

Administration

IVD – 0,01mg/kg/3min

ADRENALINE

Indication

Etat de choc

Délai d'action



30 secondes

Durée d'action



3 minutes

Présentation

Ampoule

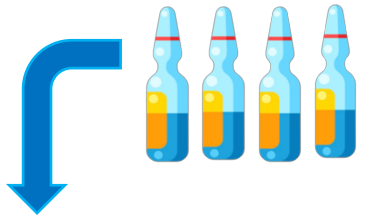
1mg dans 1 ml

5 mg dans 5 ml



Préparation

PUR



4 ampoules
de
5 mg / 5 mL



1mg/ml

Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée

Jamais de bolus

Incompatible avec du G5% ou solutés alcalins (bicarbonate, Phénytoïne, Lidocaïne)

Administration

IVSE – débuter 0,05µg/kg/min à 0,1µg/kg/min - Soit 3µg/kg/h à 6µg/kg/h

Exemple : Patient de 70kg 210µg/h à 420µg/h

ADRENALINE

Indication

Anaphylaxie

Délai d'action



30 secondes

Durée d'action



3 minutes

Présentation

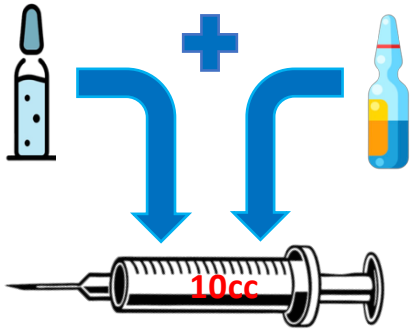
Ampoule
1mg dans 1 ml



Préparation

DILUE

9 ml
de **NaCl 0,9%**



1 ampoule
de
1 mg / 1mL

0.1mg/ml

Précautions / Risques

Incompatible avec du G5% ou solutés alcalins (bicarbonate, Phénytoïne, Lidocaïne)

Administration

IM – 0,3 à 0,5 mg
Aérosol - 0,5mg

DOBUTAMINE

Présentation

Ampoule
250 mg dans 20 ml



Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée
Jamais de bolus

Obstacle mécanique au remplissage ou à l'éjection, notamment cardiomyopathie obstructive, valvulopathie aortique, obstruction dynamique intraventriculaire.
Incompatible avec le bicarbonate et les autres solutions fortement alcalines

Indication

Etat de choc cardiogénique

Délai d'action



2 à 10 minutes

Durée d'action

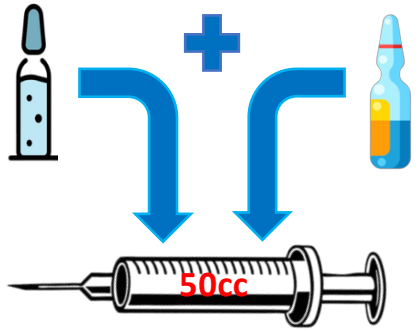


15 minutes

Préparation

DILUE

30 ml
de **G5%**
ou
NaCl 0,9%



1 ampoule
de
250 mg / 20 mL

5mg/ml

Tableau au verso

Administration

IVSE – 0,15 à 0,60 mg/kg/min

DOBUTAMINE

Indication

Etat de choc cardiogénique

Poids en kg	Posologie en µg/kg/min (Dobutamine 250 mg/50mL)									
	2	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**
40	1,0	1,9	2,9	3,8	4,8	5,8	6,7	7,7	8,6	9,6
45	1,1	2,2	3,2	4,3	5,4	6,5	7,6	8,6	9,7	10,8
50	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
55	1,3	2,6	4,0	5,3	6,6	7,9	9,2	10,6	11,9	13,2
60	1,4	2,9	4,3	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	13,0	14,4
65	1,6	3,1	4,7	6,2	7,8	9,4	10,9	12,5	14,0	15,6
70	1,7	3,4	5,0	6,7	8,4	10,1	11,8	13,4	15,1	16,8
75	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0
80	1,9	3,8	5,8	7,7	9,6	11,5	13,4	15,4	17,3	19,2
85	2,0	4,1	6,1	8,2	10,2	12,2	14,3	16,3	18,4	20,4
90	2,2	4,3	6,5	8,6	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6
95	2,3	4,6	6,8	9,1	11,4	13,7	16,0	18,2	20,5	22,8
100	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0
105	2,5	5,0	7,6	10,1	12,6	15,1	17,6	20,2	22,7	25,2
110	2,6	5,3	7,9	10,6	13,2	15,8	18,5	21,1	23,8	26,4
	Vitesse de perfusion en mL/heure									

EPHEDRINE

Indication

Hypotension au cours d'une A.G ou A.L.R

Présentation

Ampoule
30 mg dans 10 ml



Délai d'action



30 secondes

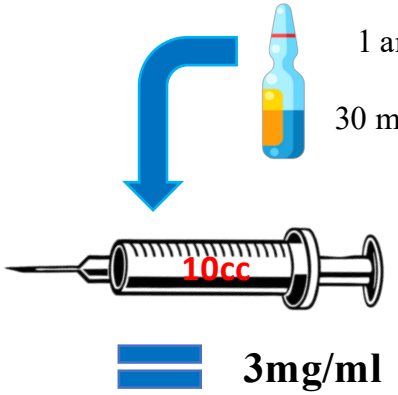
Durée d'action



10 à 20 minutes

Préparation

PUR



3mg/ml

Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée
Jamais de bolus

Prudence si : hyperthyroïdie, maladie cardiaque ischémique, arythmie ou tachycardie, pathologies vasculaires occlusives incluant l'artériosclérose, hypertension, anévrismes, glaucome à angle fermé, HBP

Administration

IVD – 3 à 6 mg toutes les 5 à 10 min selon TA

ISOPRALINE

Présentation

Ampoule
0,2 mg dans 1 ml



Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée
Jamais de bolus

Préserver de la lumière et de la chaleur
Tachycardie sinusale supérieure à 130/minute, Etats d'hyperexcitabilité auriculaire et ventriculaire, Intoxication digitalique, IDM

Indication

BAV 2ème et 3ème degrés en attente de pose de PM

Délai d'action



2 à 5 minutes

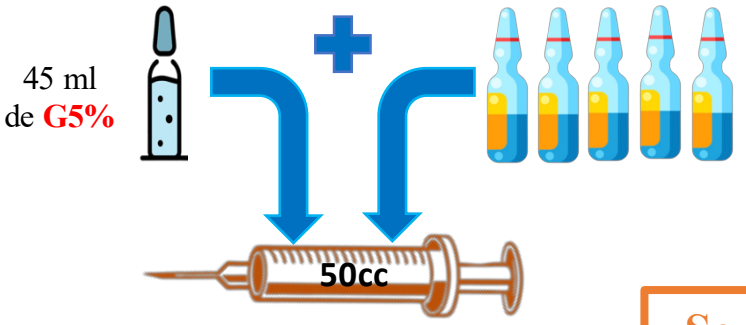
Durée d'action



3 à 7 heures

Préparation

DILUE



20µg/ml
(= 0,02mg/mL)

Seringue opaque

Administration

IVSE – par pallier selon la PM et objectif de fréquence cardiaque

NORADRENALINE

Indication

Maintien de la pression artérielle (états de choc)

Délai d'action



Immédiat

Durée d'action



5 à 10 minutes

Présentation

Ampoule
8 mg dans 4 ml



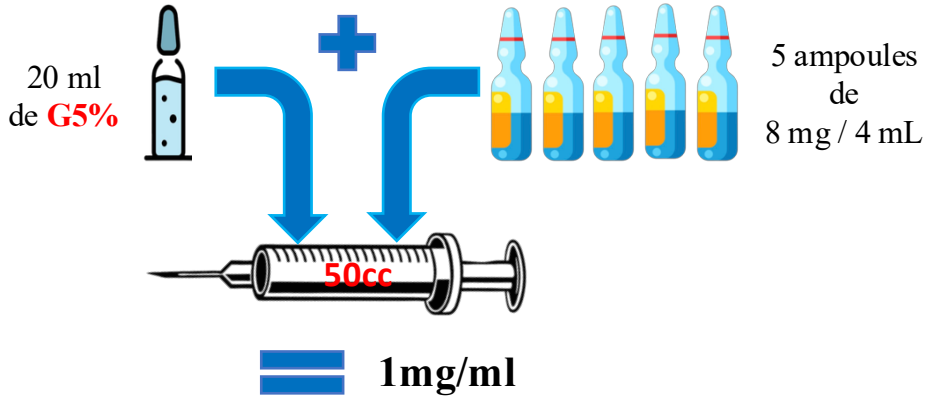
Précautions / Risques

VVP : Dédié / KTC : ligne dédiée
Jamais de bolus

Risque de nécrose périphérique, trouble du rythme, palpitations, vomissements

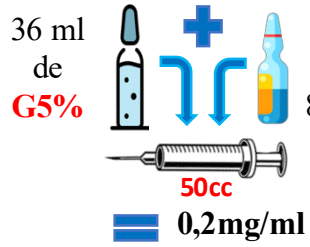
Préparation

DILUE



OÙ

DILUE



Administration

IVSE – 3µg/kg/h à 6µg/kg/h - (0,2mg/h à 0,4mg/h pour un patient de 70 kg)

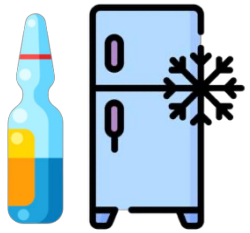
CURARES

ATRACURIUM

***si Suxaméthonium contre-indiqué**

Présentation

Ampoule
50 mg dans 5 ml



⚠ Précautions / Risques ⚠

Toujours administrer APRES l'hypnotique

Indication

Myorelaxant / Adjuvant de l'AG pour faciliter l'IOT*

Délai d'action



90 secondes

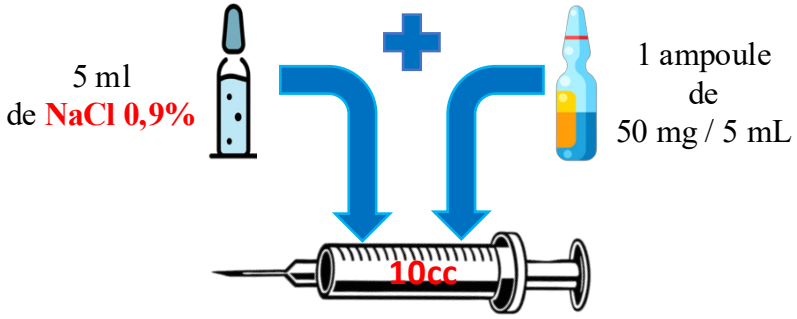
Durée d'action



15 à 35 minutes

Préparation

DILUE



5mg/ml

Administration

IVD – 0,3 à 0,6mg/kg

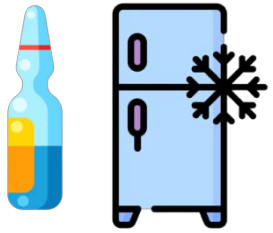
ROCURONIUM

Indication

Curare / Adjuvant de l'AG pour faciliter l'IOT

Présentation

Ampoule
50 mg dans 5 ml



Délai d'action



60 secondes

Durée d'action



30 à 40 minutes

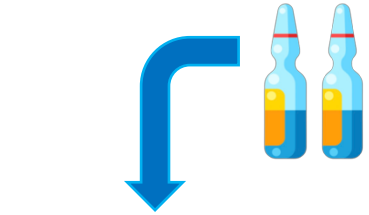
Précautions / Risques

Toujours administrer APRES l'hypnotique

Attention à la manipulation du patient curarisé.

Préparation

PUR



2 ampoules
de
50 mg / 5 mL

10mg/ml

Administration

IVD – 1,2 mg/kg

SUXAMETHONIUM

Indication

Curare / Adjuvant de l'AG pour faciliter l'IOT

Délai d'action



30 à 60 secondes

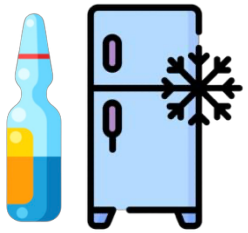
Durée d'action



6 à 13 minutes

Présentation

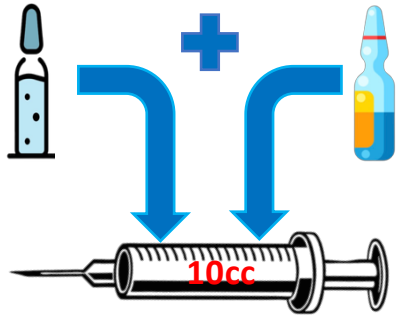
Ampoule
100 mg dans 2 ml



Préparation

DILUE

8 ml
de **NaCl 0,9%**



1 ampoule
de
100 mg / 2 mL

10mg/ml

Précautions / Risques

Toujours administrer APRES l'hypnotique

Ne pas utiliser en cas de : maladies neuro-musculaires, hyperkaliémie, brûlures étendues, troubles du rythme, insuffisance cardiaque ou crush syndrome

Administration

IVD – 1mg/kg

DIVERS

ACIDE TRANEXAMIQUE

Indication

Hémorragies dues à une fibrinolyse générale ou locale

Délai d'action



Rapide

Durée d'action



3 heures

Présentation

Ampoule
0,5 mg dans 5 ml

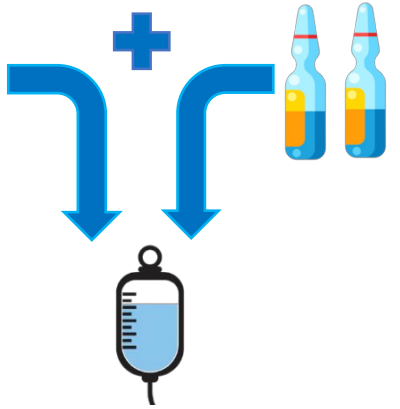


Préparation

DILUE



100 ml
de
NaCl 0,9%
ou G5%



2 ampoules
de
0,5 mg / 5 mL

Précautions / Risques

Thrombose veineuse ou artérielle aiguë, insuffisance rénale grave, antécédents de convulsions

Administration

IVL – perfusion sur 20 minutes
Enfant à partir de 1an : 20 mg/kg/jour en IVL sur 20min

GLUCAGON

Indication

Hypoglycémies sévères

Délai d'action

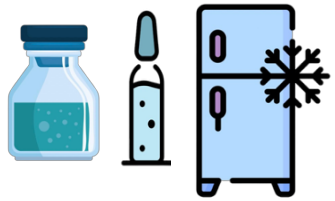
10 minutes

Durée d'action

3 à 6 minutes

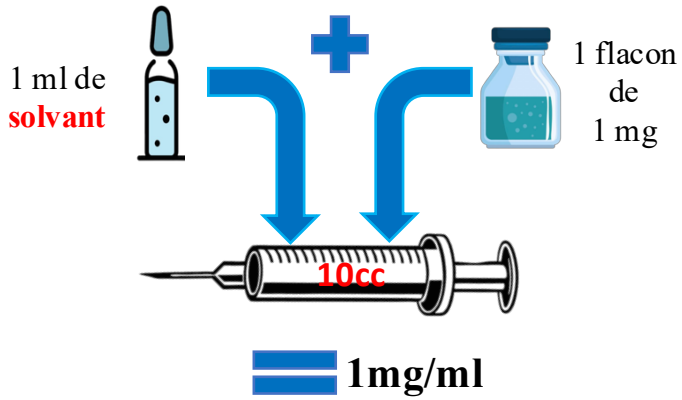
Présentation

Flacon
1 mg avec 1 ml



Préparation

DILUE



1mg/ml

Précautions / Risques

Si pas de réaction dans les 10 minutes
→ injection en IV
Après réveil administrer glucides par voie orale

Administration

IM ou SC – 1mg/ml *(Enfant < 25 kg ou < 7ans : 20 mg/kg/jour en IVL sur 20min)*

GLUCONATE DE CALCIUM

*** (> 6 mmol/L ou signes ECG)**

Présentation

Ampoule
1g dans 10 ml



Précautions / Risques

Hypercalcémie, hypercalciurie, traitement par digitaliques, ne pas administrer simultanément de la Ceftriaxone même si différentes lignes de perfusion

Indication

Hyperkaliémie menaçante*, Hypocalcémie aiguë

Délai d'action



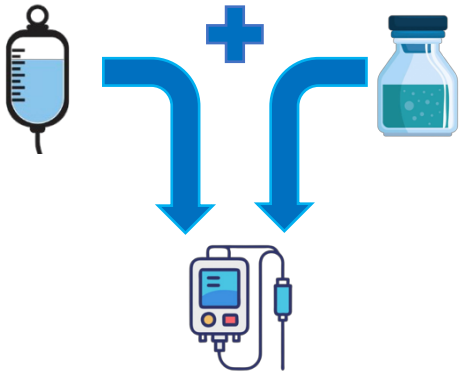
Durée d'action



Préparation

DILUE

100 ml
de **NaCl 0,9%**



2 ampoules
de
1g / 10 ml

Administration

IVL – perfusion sur 20 min

INSULINE

Indication

Acidocétose

Délai d'action

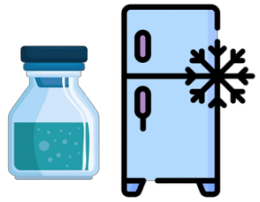


Durée d'action



Présentation

Flacon
1 000 UI dans 10 ml



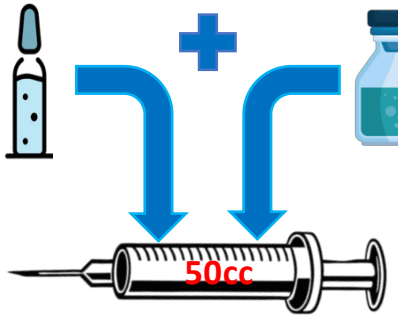
Précautions / Risques

En IVSE :
Hypokaliémie → Bilan de contrôle
Hypoglycémie → Dextro horaire

Préparation

DILUE

49,5 ml
de **NaCl 0,9%**



1UI/ml

Prélever **0,5 ml**
du flacon
(soit 50 UI)

Prélever avec seringue à Insuline



Administration

IVSE – 0,1UI/kg/h

INSULINE

Indication

Hyperkaliémie

Délai d'action

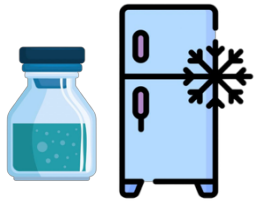


Durée d'action



Présentation

Flacon
1 000 UI dans 10 ml

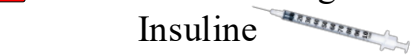


Précautions / Risques

En IVSE :
Hypokaliémie → Bilan de contrôle
Hypoglycémie → Dextro horaire

Préparation

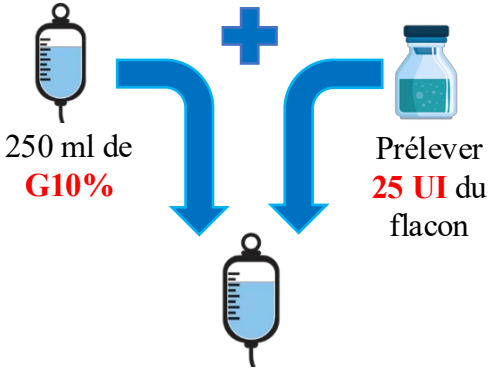
⚠ Prélever avec seringue à Insuline



DILUE

250 ml de **G10%**

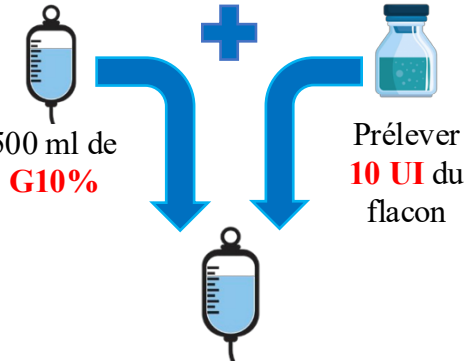
Prélever **25 UI** du flacon



DILUE

500 ml de **G10%**

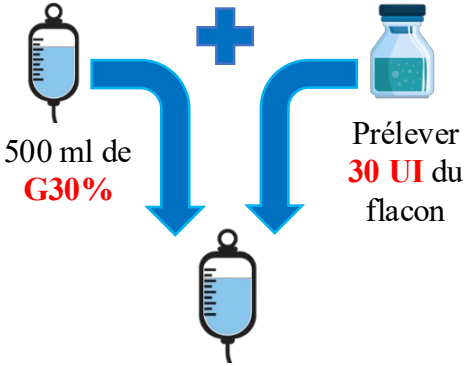
Prélever **10 UI** du flacon



DILUE

500 ml de **G30%**

Prélever **30 UI** du flacon



Administration

IVL – perfusion sur 20min

ENTRETIEN

MIDAZOLAM

Indication

Sédation

Délai d'action



2 minutes

Durée d'action



10 à 20 minutes

Sédation : 1 à 2 heures

Présentation

Ampoule

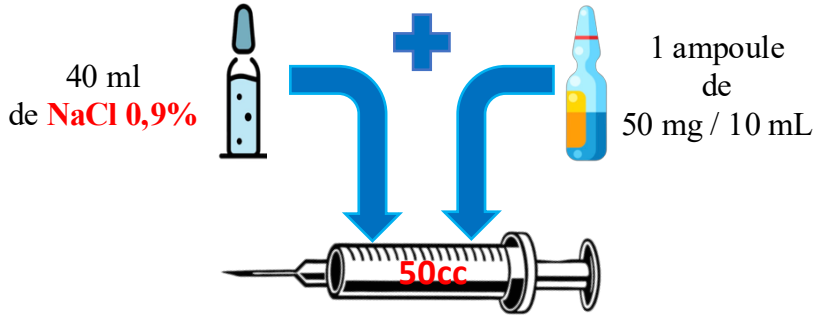
5 mg dans 5 ml

50 mg dans 10 mL



Préparation

DILUE



1mg/ml

Précautions / Risques

Dépression respiratoire potentialisée avec morphinique et hypnotique, amnésie antérograde

Administration

IVSE – Débuter 2mg/h Selon objectif Score RASS : –2/-3

SUFENTANIL

Indication

Entretien (sédation) d'un patient intubé ventilé

Délai d'action



1 à 5 minutes

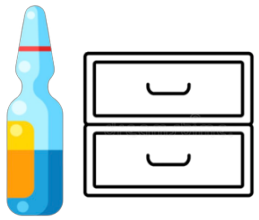
Durée d'action



10 à 45 minutes

Présentation

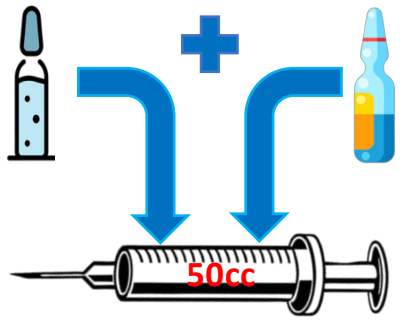
Ampoule
250 µg dans 5 ml



Préparation

DILUE

45 ml
de **NaCl 0,9%**



1 ampoule
de
250 µg / 5 mL

5µg/ml

Précautions / Risques

Ne jamais utiliser en ventilation spontanée

Administration

IVSE – débuter 10µg/h soit vitesse 2ml/h objectif selon score RASS –2/-3

INDUCTION

ETOMIDATE

Présentation

Ampoule
20 mg dans 10 ml



Précautions / Risques

Injecter AVANT le curare dans le cas d'une IOT

Indication

Hypnotique à brève durée d'action

Délai d'action



30 secondes

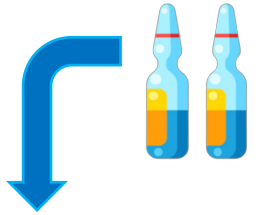
Durée d'action



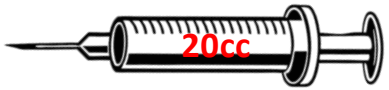
4 à 6 minutes

Préparation

PUR



2 ampoules
de
20 mg / 10 mL



2mg/ml

Administration

IVD – 0,3 à 0,5 mg/kg

KETAMINE

Indication

Analgésie

Délai d'action

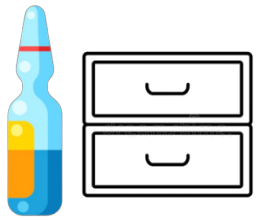
30 à 60 secondes

Durée d'action

15 minutes

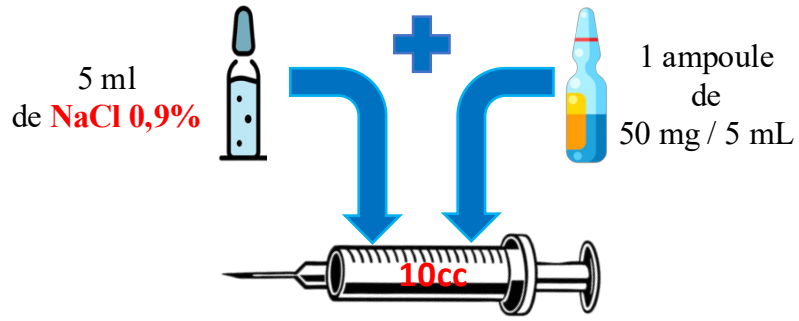
Présentation

Ampoule
50 mg dans 5 ml



Préparation

DILUE



5mg/ml

Précautions / Risques

Risque d'effets psychodysleptiques
→ instaurer une ambiance calme
Insuffisance cardiaque sévère, HTA

Administration

IVD – 0,25 mg/kg → Précédée par 1 à 2mg Valium® (Diazepam)

KETAMINE

Indication

Sédation procédurale

Délai d'action

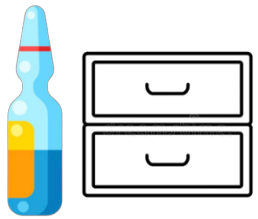
30 à 60 secondes

Durée d'action

15 minutes

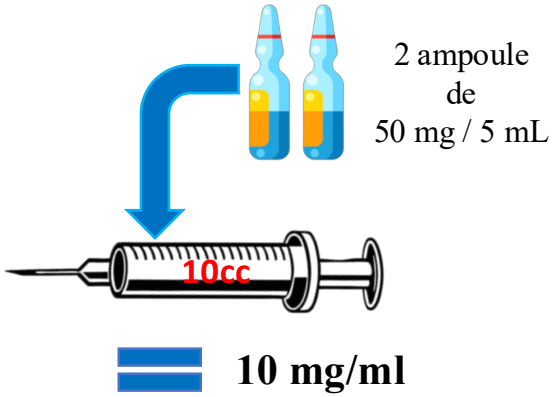
Présentation

Ampoule
50 mg dans 5 ml



Préparation

PUR



10 mg/ml

Précautions / Risques

Risque d'effets psychodysleptiques
→ instaurer une ambiance calme
Insuffisance cardiaque sévère, HTA

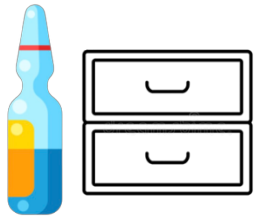
Administration

IVD – 1 mg/kg → Précédée par 1 à 2mg Valium® (Diazépam) + Dose répétées 0,25 à 1 mg/kg toutes les 5 à 10 min selon effet clinique et profondeur de la sédation

KETAMINE

Présentation

Ampoule
50 mg dans 5 ml



Précautions / Risques

Risque d'effets psychodysleptiques
→ instaurer une ambiance calme
Insuffisance cardiaque sévère, HTA

Indication

Induction pour IOT

Délai d'action



30 à 60 secondes

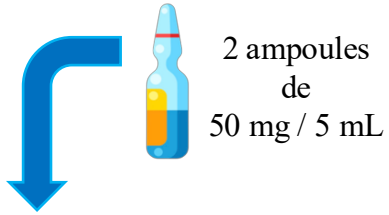
Durée d'action



15 minutes

Préparation

PUR



10mg/ml

Administration

IVDL – 1 à 2,5 mg/kg

PROPOFOL

Présentation

Ampoule
200 mg dans 20 ml



Précautions / Risques

Peut-être utilisé comme induction et entretien en cas d'état de mal épileptique
Agiter avant emploi
Hypotenseur +++, hypovolémie, apnée transitoire
Allergie à l'arachide ou au soja, patients de moins de 16 ans, femme qui allaite, hypovolémie, épilepsie non équilibrée

Indication

Agent hypnotique / Induction

Délai d'action



30 à 40 secondes

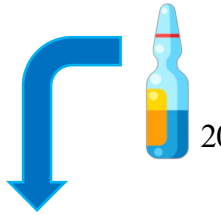
Durée d'action



5 à 10 minutes

Préparation

PUR



2 ampoules
de
200 mg / 20 mL



10mg/ml

Administration

IVDL sur 30s – 2-2.5mg/kg

THROMBOLYTIQUE

ACTILYSE

Indication

AVC ischémique, IDM, EP massive

Présentation

Flacon
10 mg dans 10 ml
50 mg dans 50 ml




Délai d'action



10 minutes

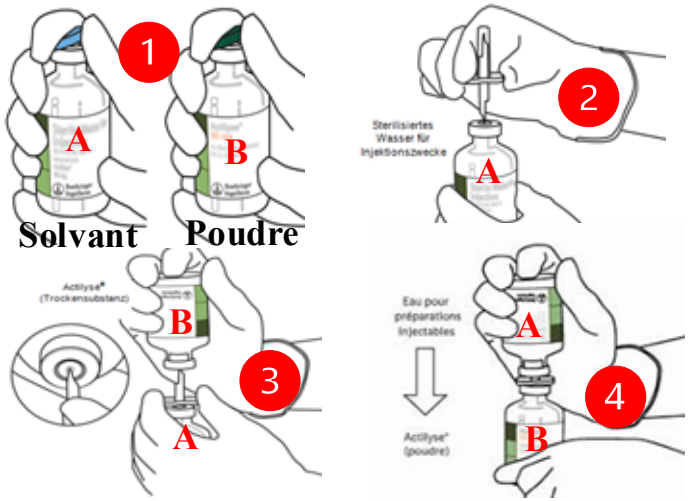
Durée d'action



20 à 40 minutes

Préparation

RECONSTITUE



Précautions / Risques

VVP dédiée
Incompatibilité : G5% et EPPI
Feuille de traçabilité à remplir et faxer à la pharmacie (39.15)
Contre indiqué en cas de risque hémorragique
TA SYS >185mm Hg ou TA DIAS >110mm Hg
Glycémie entre >400mg/dl et 50mg/dl

Administration

Tableau au verso

IVSE – Cf. Vidal car posologie précise en fonction du cas

ACTILYSE

Indication

AVC ischémique

La posologie totale recommandée est de 0,9 mg d'Altéplase/kg de poids corporel (dose maximale de 90 mg) 10% de la dose totale devant être administrée initialement par bolus intraveineux, suivi immédiatement par une perfusion intraveineuse sur 60 minutes de la dose restante.

En utilisant la concentration standard recommandée de 1 mg/ml, le volume (ml) à administrer est égal à la valeur de la dose recommandée (mg)			
Poids (kg)	**Dose totale (mg)**	**Dose en bolus (mg)**	**Dose en perfusion* (mg)**
40	36,0	3,6	32,4
42	37,8	3,8	34,0
44	39,6	4,0	35,6
46	41,4	4,1	37,3
48	43,2	4,3	38,9
50	45,0	4,5	40,5
52	46,8	4,7	42,1
54	48,6	4,9	43,7
56	50,4	5,0	45,4
58	52,2	5,2	47,0
60	54,0	5,4	48,6
62	55,8	5,6	50,2
64	57,6	5,8	51,8
66	59,4	5,9	53,5
68	61,2	6,1	55,1
70	63,0	6,3	56,7
72	64,8	6,5	58,3
74	66,6	6,7	59,9
76	68,4	6,8	61,6
78	70,2	7,0	63,2
80	72,0	7,2	64,8
82	73,8	7,4	66,4
84	75,6	7,6	68,0
86	77,4	7,7	69,7
88	79,2	7,9	71,3
90	81,0	8,1	72,9
92	82,8	8,3	74,5
94	84,6	8,5	76,1
96	86,4	8,6	77,8
98	88,2	8,8	79,4
100+	90,0	9,0	81,0

*administré à une concentration de 1 mg/ml sur 60 minutes, en perfusion à débit constant.

AUTRES

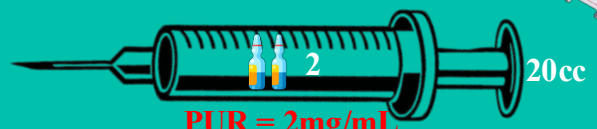
INDUCTION SEQUENCE RAPIDE

HYPNOTIQUE

HYPNOMIDATE® = ETOMIDATE

Ampoule
20 mg dans
10 ml

30
secondes



PUR = 2mg/mL

Posologie adulte & enfant > 2 ans : 0,3 – 0,5 mg/kg

OU

KETAMINE

Ampoule
50 mg dans
5 ml

30 à 60
secondes



PUR = 10mg/mL

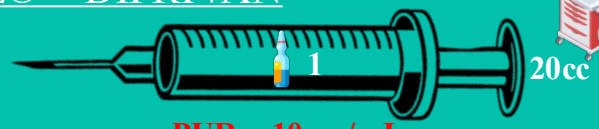
Posologie 2 - 3 mg/kg SAUF enfant < 2 ans : 3 - 4 mg/kg

OU

PROPOFOL® = DIPRIVAN

Ampoule
200 mg dans
20 ml

30 à 40
secondes



PUR = 10mg/mL

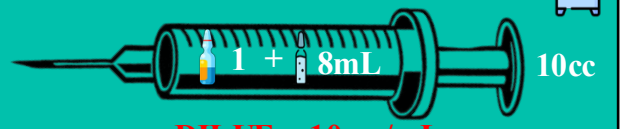
Posologie 2 – 2,5 mg/kg MAIS 1,5 mg/kg chez sujet âgé

CURARE

CELOCURINE® = SEXAMETHONIUM

Ampoule
100 mg dans
2 ml

30 à 60
secondes



DILUE = 10mg/mL

Posologie 1 mg/kg IVD

OU

ESMERON® = ROCURONIUM

Ampoule
50 mg dans
5 ml

60
secondes



PUR = 10mg/mL

Posologie 1,2 mg/kg IVD

OU

TRACURIUM® = ATRACURIUM

Ampoule
50 mg dans
5 ml

2
Minutes



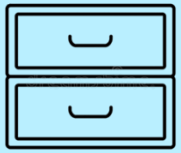
PUR = 10mg/mL

Posologie 0,5 mg/kg IVD

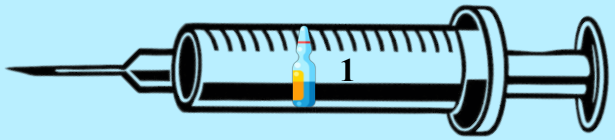
ENTRETIEN SEDATION

ALNALGESIQUE

SUFENTANIL



Ampoule
250 µg dans
5 ml



50cc

DILUER : + NaCl → 5 µg/mL

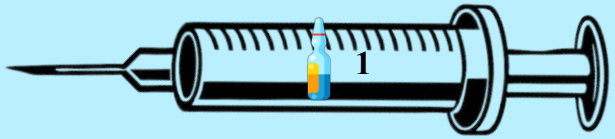
Posologie : 20 µg/h IVSE → Vitesse 4ml/h

HYPNOTIQUE

HYPNOVEL® = MIDAZOLAM



Ampoule
50 mg dans
10 ml



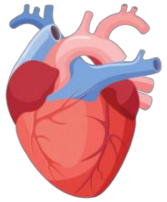
50cc

DILUER : + NaCl → 1 mg/mL

Posologie : 3 – 15 mg/h IVSE

DROGUE CHARIOT D'URGENCE





Adrénaline
(Adrénaline Aguettant®)

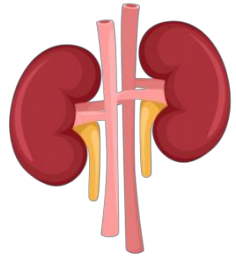
Isoprénaline
(Isuprel®)

Atropine
(Atropine Aguettant®)

Isosorbide dinitrate
(Risordan®)

Amiodarone
(Cordarone®)

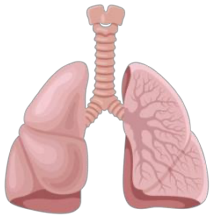
Trinitrine
(Natispray®)



Furosémide
(Lasilix®)

Méthylprednisolone
(Solumedrol®)

Nicardipine
(Loxen®)



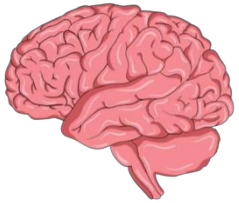
Terbutaline
(Bricanyl®)

Salbutamol
(Salbutamol fort®)



Flumazénil
(Anexate®)

Naloxone
(Narcan®)



Etomidate
(Hypnomidate®)

Propofol
(Diprivan®)

Clonazépam
(Rivotril®)

Suxaméthonium
(Célocurine®)

Midazolam
(Hypnovel®)



Chlorure de sodium 0,9%
(NaCL)

Glucose 30%
(G30%)

Sulfate de Magnésium
(MgSO4)

Gluconate de Calcium
(C12H22CaO14)

VENTILATION

VENTILATION SPONTANEE

VENTILATION EN PRESSION NEGATIVE



VENTILATION MECANIQUE

VENTILATION EN PRESSION POSITIVE



LES DIFFERENTS INTERFACE DE LA VENTILATION MECANIQUE

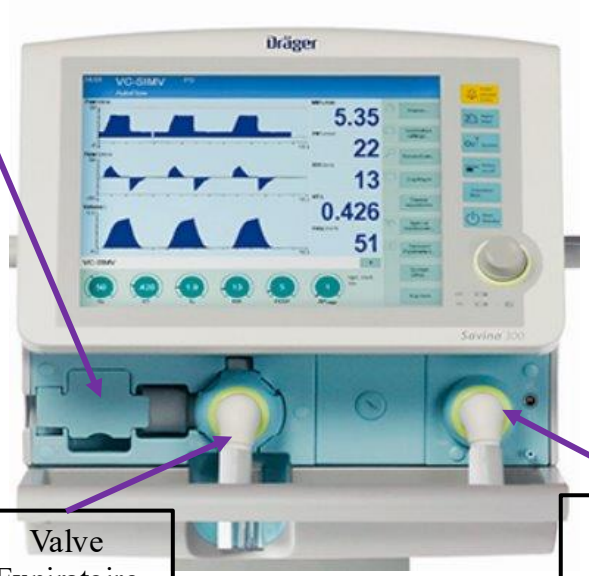
Invasif	Sonde d'intubation	**Assisté ou contrôlé**
	Trachéo(s)tomie	
Non invasif	Masque VNI	
	Masque laryngé	

RESPIRATEUR DRÄGER

SAVINA

Capteur de débit





Valve Expiratoire

Valve Inspiratoire

PARAMETRES DU SAVINA

Réglages du respirateur



Paramètres du patient

DIFFERENTS MODES VENTILATOIRES

Mode contrôlé (VC)	Mode assisté contrôlé (VAC)	Mode assisté (VSAi)
Assure seul la ventilation du patient	Participation partielle du patient sous contrôle	Patient autonome avec de l'aide

VENTILATION MECANIQUE

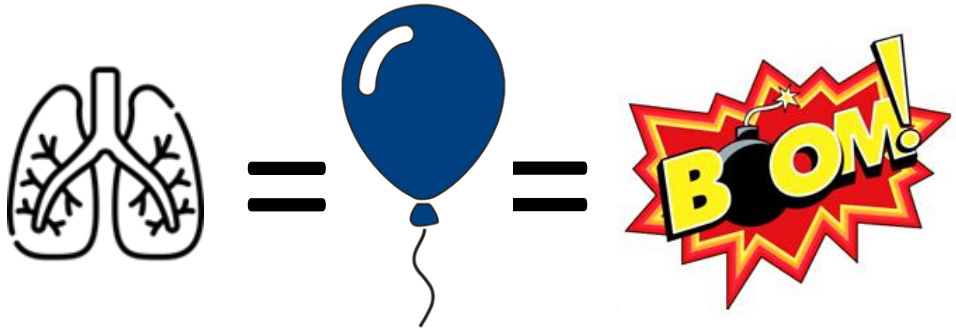
MODE CONTRÔLE (VC)

1 **Je règle** :
- Volume (VT)
- FR
- PEP
- FiO_2

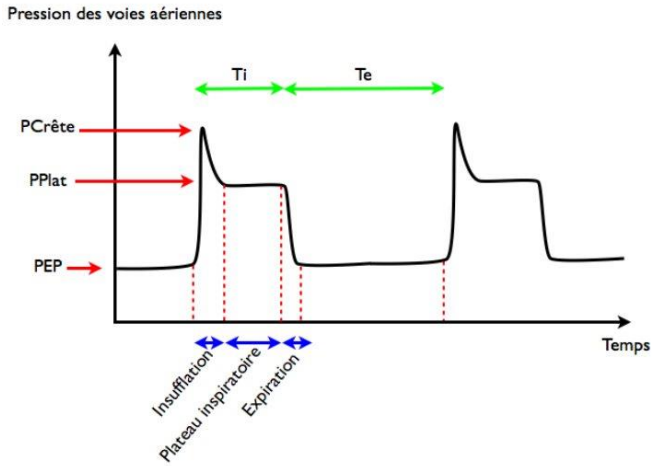
2 **Je surveille** :
- Pression de plateau (Pplat)
- Pression de crête (Paw)



FiO2 = Fraction en oxygène dans le mélange gazeux
Air ambiant = 21% de FiO2
21 % < FiO2 < 100 %



Barotraumatisme



VENTILATION MECANIQUE

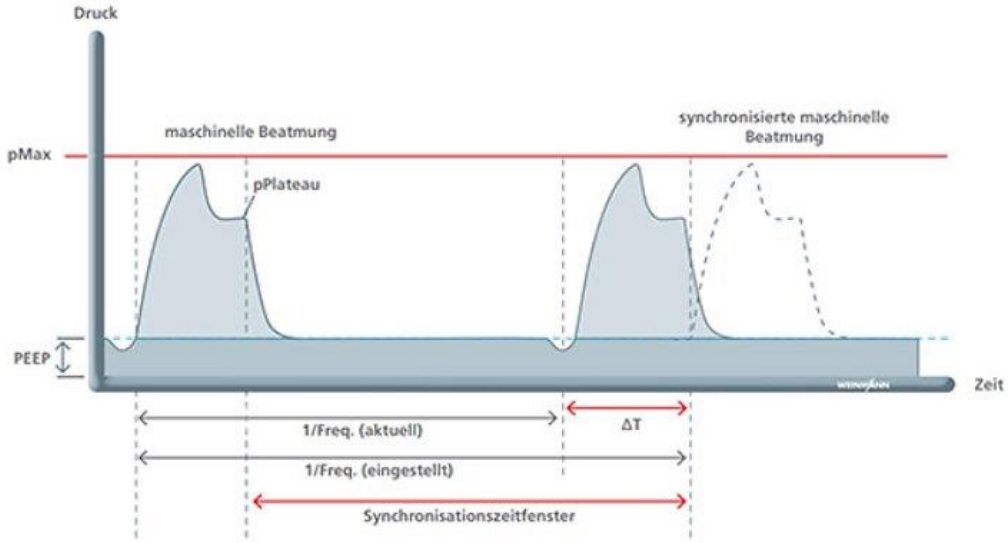
MODE ASSISTE CONTRÔLE (VAC)

1 **Je règle** :
- Volume (VT)
- FR
- PEP
- FiO_2

TRIGGER

2 **Je surveille** :
- Pression de plateau (Pplat)
- Pression de crête (Paw)





VENTILATION MECANIQUE

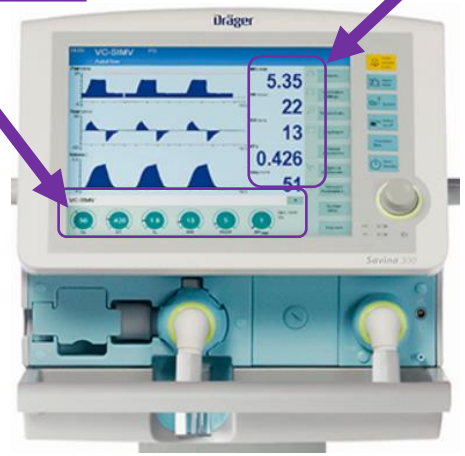
MODE ASSISTE (VSAi)

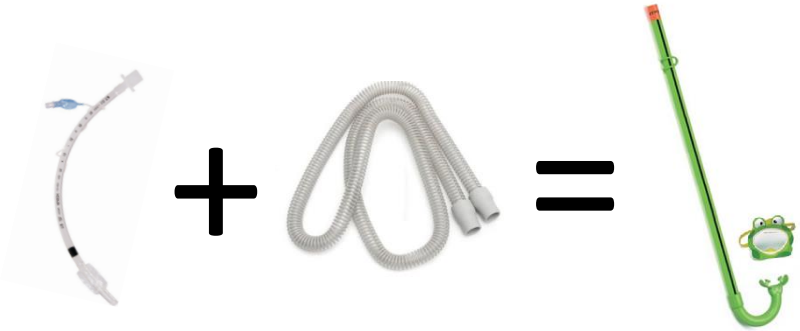
1 **Je règle** :

- Niveau Aide (Δ AI)
- PEP
- FiO_2

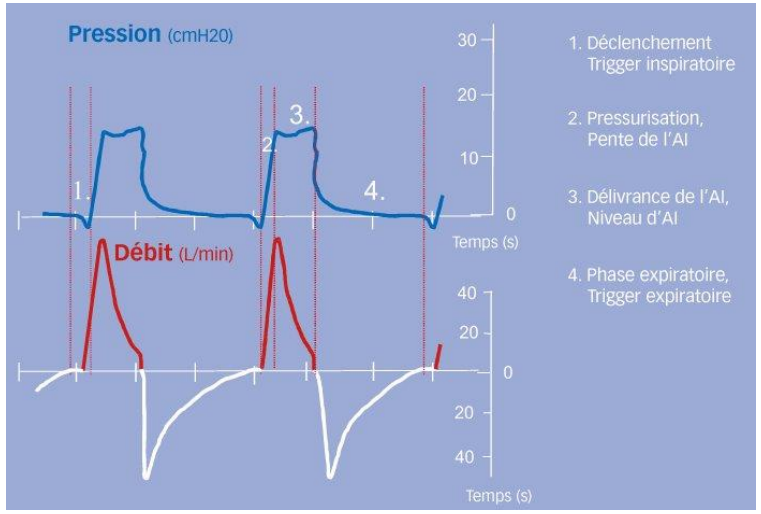
2 **Je surveille** :

- Volume (VT)
- FR
- Vmin (Volume minute = VT x FR)



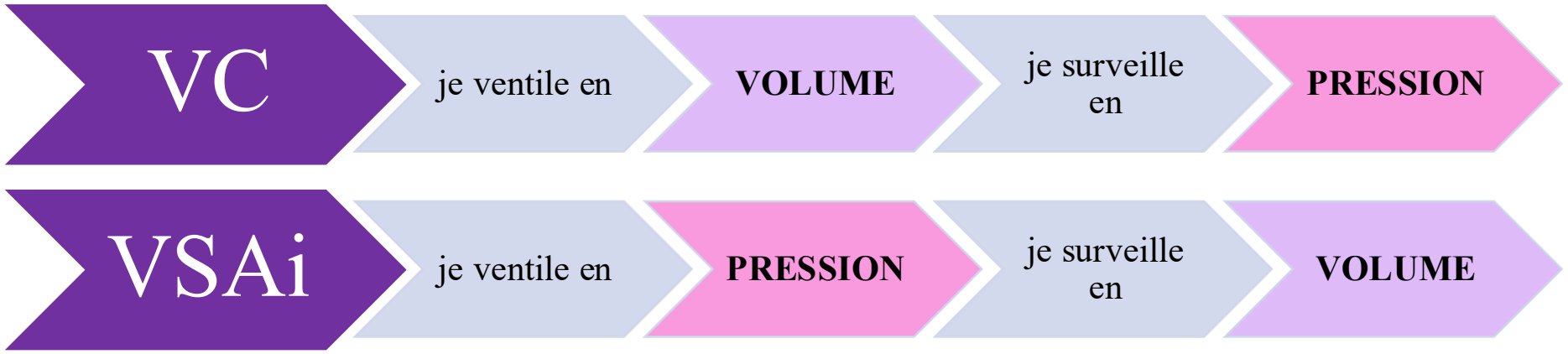


Espace mort

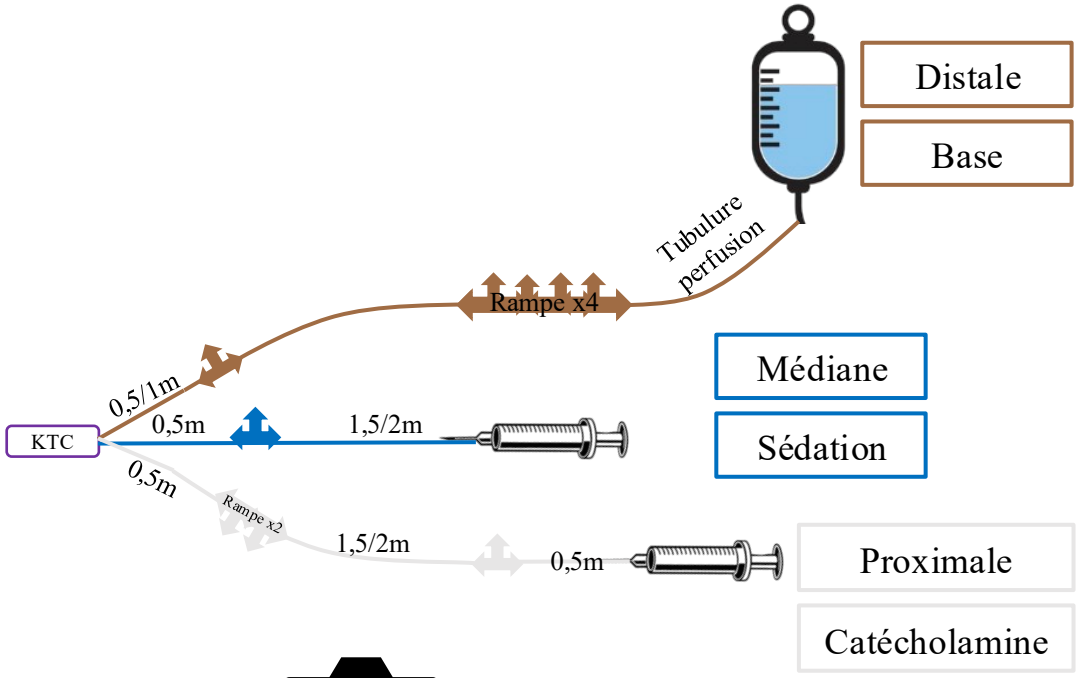


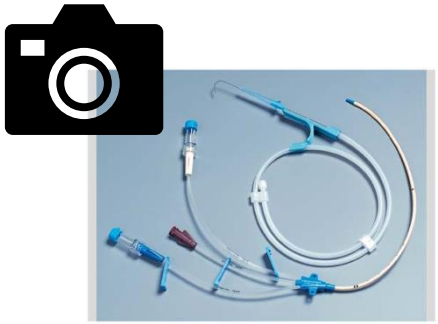
VENTILATION MECANIQUE

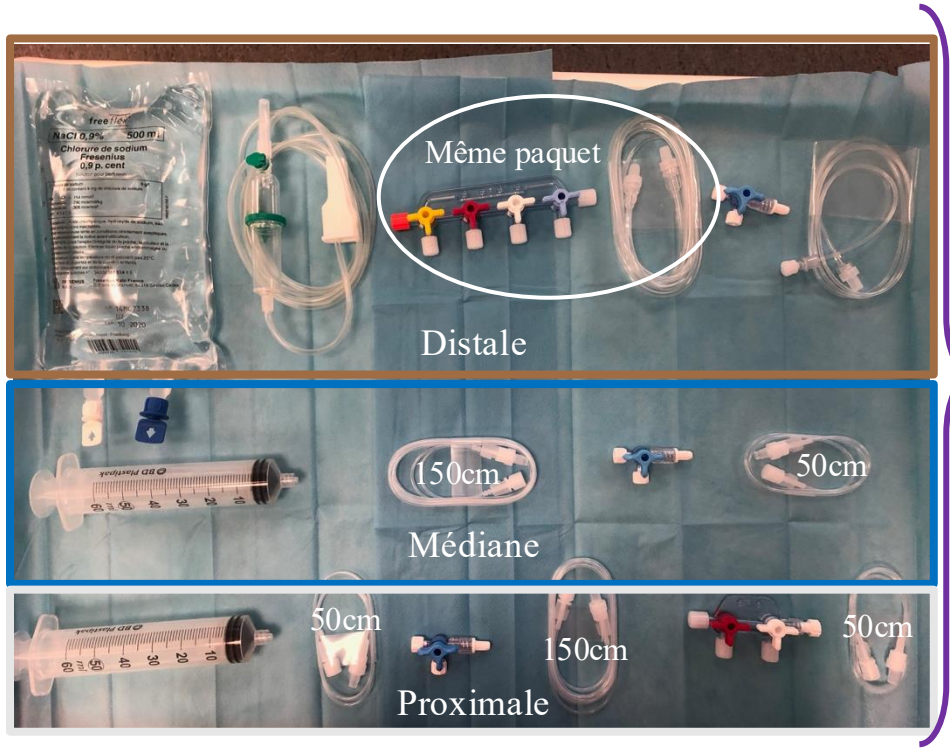
TAKE HOME MESSAGE



KTC

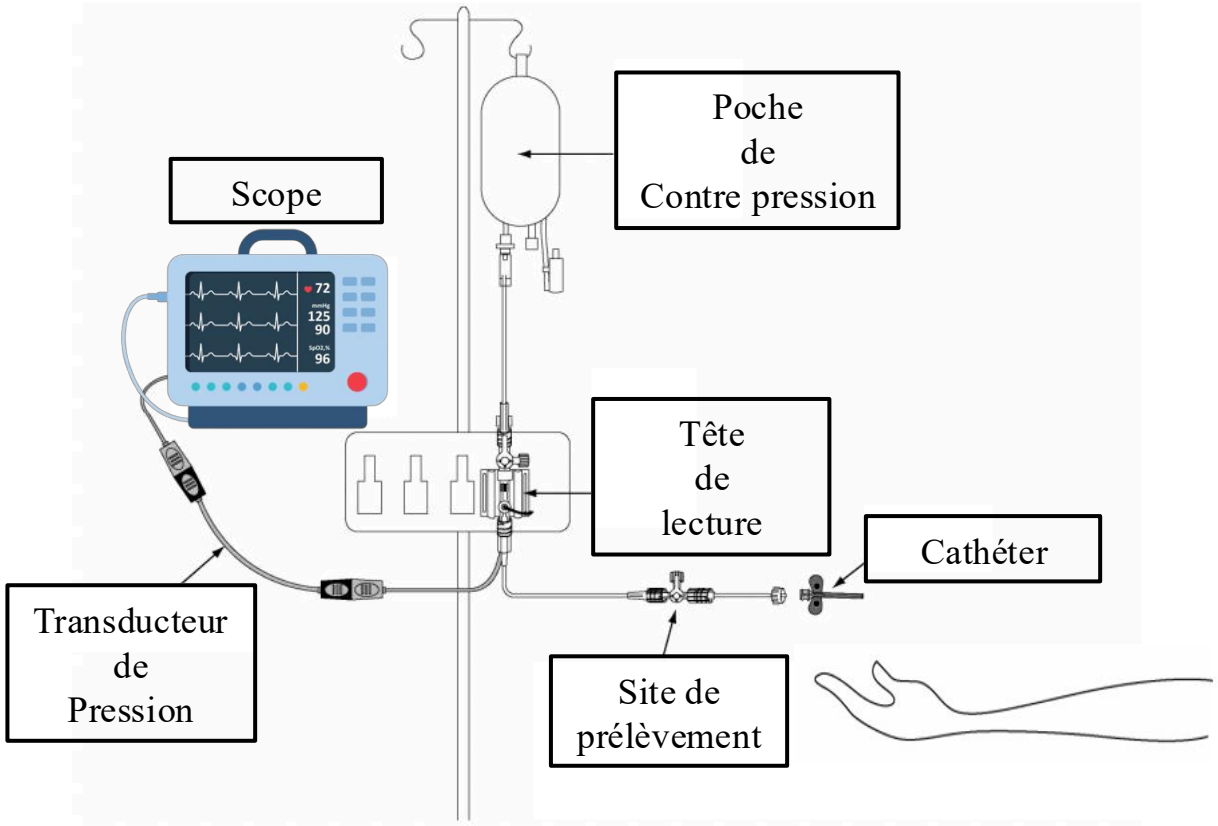

Distale
Base
Tubulure perfusion
Rampe x4
Médiane
Sédation
0,5/1m
KTC
0,5m
1,5/2m
0,5m
Rampe x2
1,5/2m
0,5m
Proximale
Catécholamine




Même paquet
Distale
150cm
50cm
Médiane
50cm
150cm
50cm
Proximale
KTC



KTA



Transducteur de Pression



Site de prélèvement



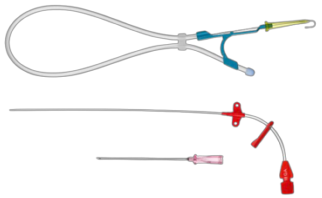
Poche de Contre pression



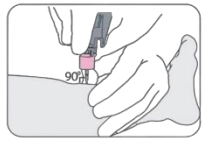
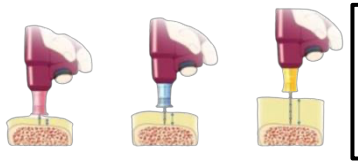
Tête de lecture



Cathéter



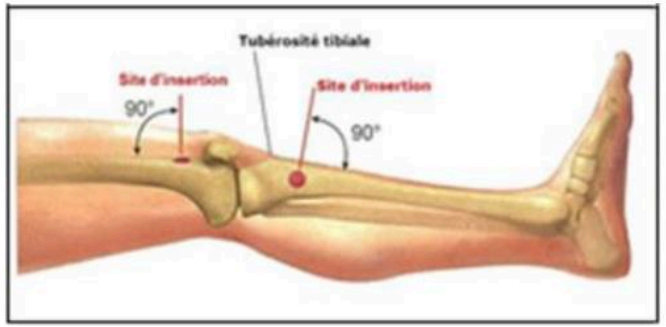
KT INTRA OSSEUX

AIGUILLES NIO® INFANT (ou NIO® I)	AIGUILLES EZ-IO®
  Prématuré et nouveau-né < 1 an	 Rose Patient entre 3 & 39kg | Bleu Patient ≥ 3kg | Jaune Patient ≥ 40kg
Gants	
	Perceuse
Set de pansement	Set de pansement
Antiseptique (Chloraprep® 10,5 ml)	Antiseptique (Chloraprep® 10,5 ml)
Robinet à rallonge 	Raccord EZ connect ® 
Fixateur Nio infant® inclus 	Fixateur EZ stabilizer® 
2 posiflush® de 10ml (NaCl 0.9%)	
Billot réalisé avec un linge roulé	

KT INTRA OSSEUX

SITE DE PONCTION

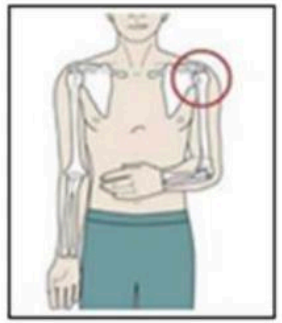
Par ordre de priorité : tibia proximal, tibia distal, fémur distal, tête de l'humérus **Aiguilles EZ-IO uniquement** (> 5 ans).



Fémur distal, tibia proximal



Tibia distal



Tête humérale

POSE D'UNE AIGUILLE

Pour valider le choix de l'aiguille EZ-IO®, **il faut qu'un repère noir (5 mm) sur l'aiguille soit visible** lorsque celle-ci est posée contre l'os au travers des tissus sous-cutanés.





DRAIN THORACIQUE

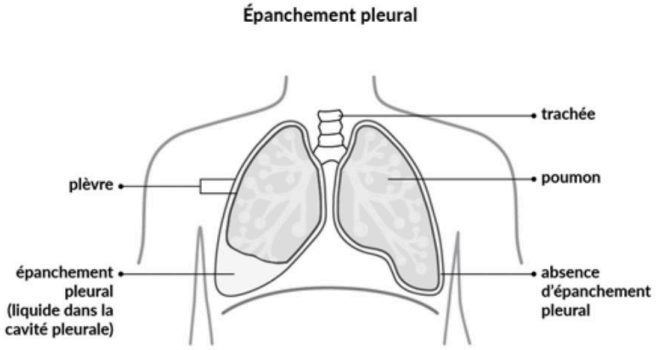
Epanchement pleural

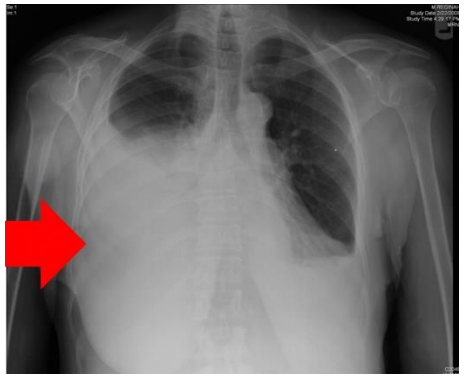
Accumulation de liquide dans la cavité pleurale

Diagnostique réalisé à l'aide d'une radio thorax ou TDM

Symptômes : dyspnée, douleur thoracique (majorée à l'inspiration)

Principales causes : cancer, tuberculose, pneumopathie, insuffisance cardiaque





Pneumothorax

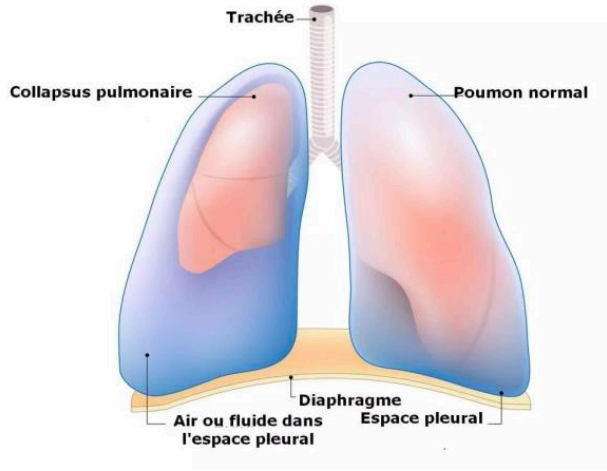
Présence d'air entre les deux couches de la plèvre

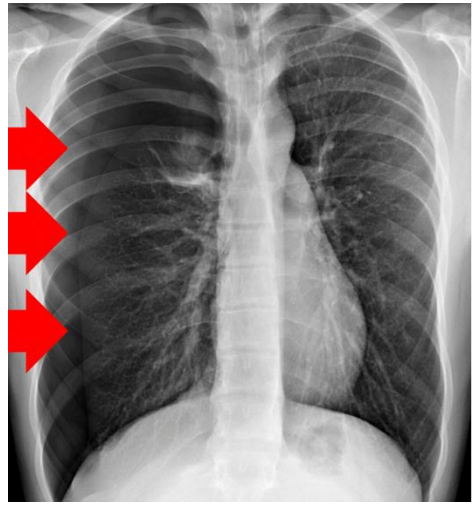
Entraîne un collapsus pulmonaire partiel au complet

Pneumothorax spontané primitif (sans pathologie pulmonaire)

Pneumothorax spontané secondaire (BPCO, tuberculose, cancer...)

Symptômes : dyspnée, douleur thoracique



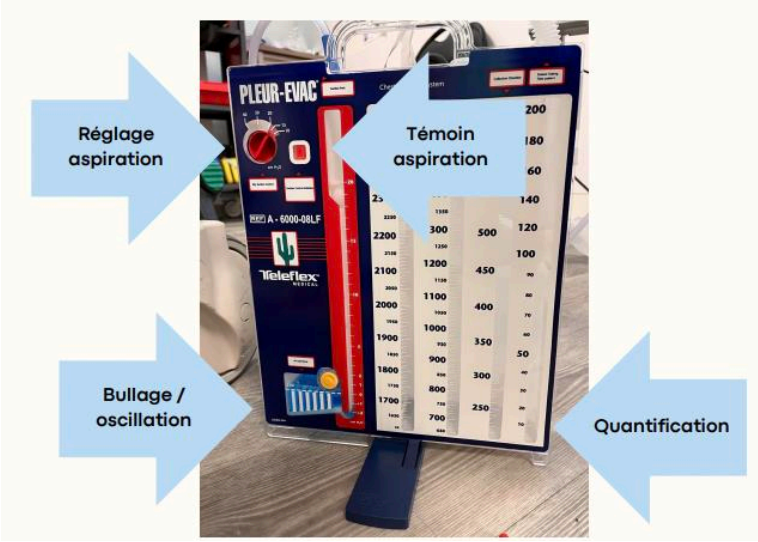


DRAIN THORACIQUE

POSE DU DRAIN THORACIQUE



PLEUREVAC®



MONTAGE DU DRAIN THORACIQUE

